ORIGEM DO DOCUMENTO:	Núcleo de Segurança do Paciente		
TÍTULO:			Nº DOC:
Meta 2 – Protocolo de Comunicação Efetiva			PRT.NSP.004
DATA 1ª VERSÃO	DATA DESTA VERSÃO	VERSÃO Nº	PRÓXIMA REVISÃO
10/12/2025	10/12/2025	01	10/12/2027

1. OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é garantir a efetividade da comunicação entre profissionais da assistência, promovendo a prevenção de erros relacionados a falha de comunicação a fim de reduzir a ocorrência de incidentes, e com isso, assegurar que o paciente seja submetido ao tratamento e/ou serviço para a qual se destina.

2. ABRANGÊNCIA

O protocolo deverá ser aplicado em todos os ambientes de prestação do cuidado de saúde (unidades de internação, ambulatório, urgência, centro cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, uti adulto e pediátrico, endoscopia, entre outros) em que sejam realizados procedimentos, quer terapêuticos, quer diagnósticos da FCECON.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

Na saúde um dos desafios para garantir a segurança do paciente no ambiente hospitalar é enfatizar a comunicação efetiva como meta a ser atingida pela equipe interdisciplinar, garantindo uma assistência de qualidade, gerando impacto direto sobre os resultados, como também, proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso com assistência livre de danos. Uma vez que há falhas nos processos de comunicação eletrônica, verbal e escrita essas são reconhecidas como contribuintes para a ocorrência de eventos adversos, inclusive de óbitos.

A informação é considerada ativo estratégico e deve chegar até cada público-alvo de forma clara e objetiva, sustentando condutas padronizadas e a apropriação, por parte do público-alvo, de conteúdo atualizado e de boa qualidade. A disseminação de uma informação cujo foco é a segurança do paciente, deve ser planejada para atingir o público-alvo pretendido e ser convertida em ação segura. Nesse sentido, esse protocolo contém diretrizes para facilitar a comunicação através do uso de ferramentas que devem ser aplicadas na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON), com o objetivo de minimizar a ocorrência de incidentes e eventos adversos relacionados a falha de comunicação entre a equipe multiprofissional. Espera-se que todo o processo de troca de informação entre pessoas deva resultar em compreensão sobre o que está sendo comunicado em todas as unidades de cuidado.

4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Diante da necessidade de garantir uma comunicação clara, precisa, completa e sem ambiguidade para o receptor, o Núcleo de Segurança do Paciente vem implementando os procedimentos operacionais específicos em determinadas situações da assistência a fim de alcançar a melhoria da efetividade na comunicação.

5. ORIENTAÇÕES GERAIS:

A segurança do paciente depende do trabalho em equipe e é melhorada apenas quando a informação é compartilhada (SALAS *et al* 2003). Sabe-se que alguns fatores podem afetar a qualidade da comunicação. São eles:

- Privação do sono em jornadas de trabalho longas;
- Descontinuidade da assistência;
- Atendimentos que extrapolam a capacidade instalada da Unidade/Setor de Saúde;
- Ausência de protocolos que padronizem a comunicação.

A recomendação de ouvir e repetir para o interlocutor a informação/ordem/prescrição recebida é considerada uma medida de segurança para

garantir uma comunicação clara, precisa, completa e sem ambiguidade para o receptor.

- Atentar para o uso de gestos, expressões visuais, imposição da voz e sinais paralinguísticos, pois são determinantes para uma relação.
- Promover a comunicação assertiva de forma direta, clara, aberta, sincera, objetiva, transparente, respeitosa e efetiva para a transmissão da informação e, principalmente, sem provocar constrangimentos às outras pessoas.

5.1. Transmissão/Transferência de Informação na Transição do Cuidado

Ocorre principalmente entre profissionais. Pode acontecer em diversos espaços: da recepção aos profissionais que ficam no corredor, dos corredores para o salão de infusão, da sala de quimioterapia para a sala da radioterapia, etc.

Trata-se de um momento crucial do processo assistencial para garantir a continuidade do cuidado e organizar processos assistenciais. Importante ponderar que a relação entre os profissionais proporciona repercussões na cultura de segurança.

A transmissão das informações deve ser realizada nas seguintes formas:

- Passagem de plantão presencial a cada troca de turno para todas as categorias profissionais com atualização do senso uma vez ao dia no período noturno;
- Visitas interdisciplinares com o envolvimento da equipe (Núcleos, Gerências, entre outros) e, quando possível, do paciente e/ou familiares;
- Discussões interdisciplinares para construção de plano de ação pós evento adverso grave ou *never events*;
- Rondas em setores envolvendo toda a equipe multiprofissional e a gestão.

5.2. Registro em Prontuário

- Um dos quesitos que mais impacta na segurança do paciente é o registro assertivo, uma vez que informações legítimas são indispensáveis para uma assistência segura. Portanto torna-se necessário que os registros em prontuários sejam completos, atualizados, precisos, fidedignos, legíveis e com terminologia própria da profissão.
- O uso de siglas e abreviaturas deverá ser evitados até que seja padronizado o siglário da FCECON.
- As prescrições medicamentosas e de assistência de enfermagem devem ser checadas com nome e carimbo do profissional que prestou o cuidado.
- Registrar todas as atividades assistenciais prestadas ao paciente no prontuário do, nas contingências, e nos demais formulários manuais.;
- Utilizar os recursos de comunicação visual/escrita para identificação do paciente de acordo com “Protocolo Segurança do paciente: identificação do paciente da FCECON.
- Preencher os formulários institucionais padronizados para: Passagem de Plantão, durante as transferências, no recebimento dos pacientes críticos, durante as visitas transdisciplinares/rounds, SBAR, controle das unidades, livros de ocorrência das unidades, formulários de notificação de eventos adversos e demais formulários utilizados para composição do Prontuário do Paciente.
- Notificar os eventos adversos relacionados as falhas na comunicação entre os profissionais de saúde no formulário de Notificação de Incidentes / eventos Adversos da Fundação.

5.3. Visita Multidisciplinar na UTI Adulto

5.3.1. Objetivo da Visita Multidisciplinar na UTI Adulto

A visita multidisciplinar na UTI Adulto tem como objetivo promover o cuidado integral, seguro e centrado no paciente crítico, por meio da integração dos saberes das diferentes

categorias profissionais, garantindo alinhamento das condutas, tomada de decisão compartilhada, prevenção de eventos adversos e otimização dos desfechos clínicos.

5.3.2. Local de Realização

A visita multidisciplinar deverá ser realizada à beira do leito do paciente, na UTI Adulto, permitindo:

- Avaliação direta das condições clínicas do paciente;
- Verificação de dispositivos invasivos e não invasivos;
- Conferência de identificação do paciente;
- Discussão imediata do plano terapêutico individualizado.

Quando necessário, complementações poderão ser discutidas em sala de apoio da unidade, respeitando a confidencialidade das informações.

5.3.3. Frequência da Visita

A visita multidisciplinar deverá ocorrer três vezes na semana, sendo nas segundas, quartas e sextas-feiras, preferencialmente no período da manhã, após a estabilização inicial dos pacientes e atualização das evoluções clínicas.

Visitas adicionais poderão ser realizadas conforme necessidade clínica, intercorrências, admissões recentes ou mudanças significativas no quadro do paciente.

5.3.4. Profissionais Envolvidos

A visita multidisciplinar deverá contar, sempre que possível, com a participação dos seguintes profissionais:

- **Médico Intensivista**

Coordenar a visita;

Apresentar o quadro clínico atual do paciente;

Definir e alinhar condutas médicas, metas terapêuticas e prognóstico;

Avaliar necessidade de intervenções cirúrgicas, exames e ajustes terapêuticos.

- **Enfermeiro da UTI**

Apresentar dados assistenciais relevantes (sinais vitais, balanço hídrico, cuidados com dispositivos, integridade da pele, risco de LPP);

Verificar adesão aos protocolos institucionais;

Identificar riscos assistenciais e eventos adversos;

Planejar cuidados de enfermagem e garantir continuidade do cuidado.

- **Técnico de Enfermagem**

Contribuir com informações da assistência direta;

Relatar intercorrências do plantão;

Auxiliar na execução das condutas definidas durante a visita.

- **Fisioterapeuta**

Avaliar condição respiratória e motora;

Definir estratégias de ventilação mecânica, desmame ventilatório e mobilização precoce;

Orientar condutas para prevenção de complicações pulmonares e musculoesqueléticas.

- **Farmacêutico Clínico**

Avaliar prescrição medicamentosa quanto a dose, interações, compatibilidades e ajustes conforme função renal/hepática;

Contribuir para o uso seguro de medicamentos;

Apoiar decisões relacionadas à antibioticoterapia e terapias específicas.

- **Nutricionista**

  Avaliar estado nutricional;

  Definir e ajustar plano nutricional (enteral/parenteral);

  Monitorar tolerância, aporte calórico e proteico.

- **Psicólogo (quando disponível)**

  Avaliar aspectos emocionais do paciente e familiares;

  Apoiar a equipe em situações de estresse, luto ou comunicação difícil;

  Contribuir para o cuidado humanizado.

- **Fonoaudiólogo**

  O fonoaudiólogo deverá participar da visita multidisciplinar sempre que houver pacientes com risco ou presença de alterações na deglutição, comunicação ou funções orofaciais, especialmente no pós-operatório de cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias torácicas, pacientes traqueostomizados, intubados por tempo prolongado ou em processo de desmame ventilatório.

  - Principais atribuições durante a visita:
  - Avaliar e acompanhar a função de deglutição, identificando risco de broncoaspiração;
  - Definir, em conjunto com a equipe, o momento seguro para início ou progressão da via oral;
  - Orientar quanto à consistência adequada da dieta e necessidade de adaptações;
  - Avaliar e reabilitar a comunicação do paciente, especialmente em casos de traqueostomia ou limitações neurológicas;
  - Contribuir para estratégias de decânulação segura, quando aplicável;

- Orientar a equipe e familiares quanto aos cuidados fonoaudiológicos;
- Registrar evolução e condutas no prontuário.

5.3.5. Etapas da Visita Multidisciplinar

Preparação

Revisão prévia dos prontuários;

Atualização de exames, prescrições e evoluções;

Organização da equipe para início da visita.

Discussão à Beira do Leito

Identificação segura do paciente;

Apresentação do quadro clínico e evolução;

Discussão de diagnósticos, riscos e metas diárias;

Avaliação dos dispositivos, prevenção de infecções, LPP e quedas;

Definição conjunta do plano terapêutico.

Definição de Metas e Condutas

Estabelecimento de metas claras e mensuráveis;

Distribuição de responsabilidades entre os profissionais;

Planejamento de curto e médio prazo.

5.3.6. Registro em Prontuário

Registro das decisões e condutas acordadas;

Atualização dos planos de cuidado multiprofissional;

Garantia de rastreabilidade das informações.

5.3.7. Comunicação e Segurança do Paciente

Durante a visita, deverão ser observados:

Comunicação clara, objetiva e respeitosa;

Incentivo à participação ativa de todos os profissionais;

Valorização da cultura de segurança;

Identificação precoce de riscos e oportunidades de melhoria.

5.3.8. Resultados Esperados

Redução de eventos adversos;

- Melhoria da qualidade assistencial;
- Maior adesão aos protocolos;
- Otimização do tempo de internação;
- Cuidado centrado no paciente e na família.

6. COMUNICAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES ENTRE SERVIÇOS

Refere-se a situações de transferência de pacientes entre as unidades de diagnóstico, terapêutica ou qualquer outra unidade que funcione como base de estabilização, mesmo que de caráter privado ou contratualizado.

A solicitação de transferência de pacientes entre serviços deve ser médica e, portanto, o médico solicitante do exame deverá assinar com nome e CRM legíveis os formulários elaborados pela FCECON com as informações relativas ao paciente e ao seu transporte, e assinar o Formulário de Transferência Intra e Inter Hospitalar. Além disso, deve realizar as solicitações de transferência através de contato prévio com a equipe de enfermagem e medica da clínica.

A responsabilidade do paciente transferido é do médico solicitante até que o mesmo seja recebido pelo médico da unidade receptora no caso de transferência em viatura de suporte básico de vida.

NOTA: 1. Sempre que possível, a transferência deverá ser comunicada aos familiares e ocorrer na presença dos mesmos ou responsável.

2. Seguir Protocolo de Transporte Seguro e Remoção.

7. FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO EFETIVA

7.1. SBAR

A ferramenta SBAR estrutura a comunicação para reduzir chances de erros e omissões durante a passagem de plantão dos profissionais de saúde. O método oferece diretrizes claras para promover uma manutenção da estrutura de trabalho e reduzir ao máximo a chance de erros e omissões durante a troca de turnos. É um instrumento válido para comunicação nos processos de passagem de plantão, transferência intra e inter hospitalar, levando com que as informações sejam passadas de forma clara e objetiva.

Os elementos da ferramenta SBAR: **SITUAÇÃO, BACKGROUND/ HISTÓRIA PRÉVIA, AVALIAÇÃO e RECOMENDAÇÃO**, funcionam como um check-list que garante que a troca de informações será completa para garantir a segurança do paciente.

S – SITUAÇÃO:

- O que está acontecendo com o paciente?
- Identifique-se;
- Identifique a unidade do paciente;
- Explique resumidamente o problema. Qual é, quando aconteceu ou iniciou e qual a sua gravidade;
- Determine a causa da sua preocupação.

B – BACKGROUND/ HISTÓRIA PRÉVIA:

- Qual é o contexto e histórico clínico?
- Forneça informações pertinentes dos antecedentes relacionados com a situação que podem incluir: diagnóstico de internação, data de admissão, lista das medicações em uso, alergias, sinais vitais mais recentes, data e hora em que foi realizado qualquer

exame laboratorial e os resultados dos exames anteriores para comparação, resumo do tratamento até o momento.

A – AVALIAÇÃO:

- O que mudou?
- Diga o que você considera que seja o problema: mudanças que ocorrem em relação à avaliação anterior, a condição do paciente instável ou se agravando.

R – RECOMENDAÇÃO:

- O que eu faria para corrigi-lo?

- Diga qual a sua recomendação ou solicitação: tratamentos específicos, exames necessários, o paciente precisa ser avaliado agora?

A proposta desta ferramenta é realizar uma comunicação breve e concisa com informações de importância crítica transmitidas em uma estrutura previsível.

A estrutura SBAR ajuda a desenvolver as habilidades de pensamento crítico. Logo, a pessoa que inicia a comunicação sabe o que deve dizer antes mesmo de pegar o telefone. Sua conclusão pode não ser a resposta, mas há claramente um valor na definição da situação.

Exemplo: comunicação verbal e escrita – modelo SBAR

NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO, REGISTRO / NÚMERO DO PRONTUÁRIO	Dados do paciente preenchidos no formulário.
S – SITUAÇÃO	Aqui é a enfermeira *ML* da Quimioterapia e estou acompanhando o paciente Sr. *PPP*. Ele teve uma dor torácica de forte intensidade há cerca de 5 minutos, acompanhada de dispneia e sudorese.
B – BACKGROUND/ HISTÓRIA PRÉVIA	É um homem de 68 anos, com diagnóstico de câncer de próstata, está fazendo quimioterapia, no 6 ciclo e que sofreu uma queda ontem, sem complicações.

A – AVALIAÇÃO	Pedi um eletrocardiograma e minha preocupação é que ele esteja tendo um infarto ou embolia pulmonar.
R – RECOMENDAÇÃO	Seria muito importante que o Sr. viesse aqui imediatamente.

7.2. KANBAM

Esta ferramenta tem por objetivo estabelecer diretrizes para a sua utilização como instrumento de apoio ao Protocolo de Comunicação Efetiva, garantindo a transmissão clara, oportuna, padronizada e rastreável de informações assistenciais críticas, promovendo a segurança do paciente e a continuidade do cuidado no ambiente hospitalar.

7.2.1. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a todos os setores assistenciais do hospital, incluindo unidades de internação, UTI, centro cirúrgico, pronto atendimento, unidades diagnósticas e demais áreas envolvidas direta ou indiretamente no cuidado ao paciente.

8. INDICADORES - ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO E INDICADORES

8.1. MONITORAMENTO

Todos os incidentes envolvendo falhas na comunicação devem ser notificados pelos pacientes e/ou profissionais de saúde no formulário de Notificação de Incidentes / Eventos Adversos do Núcleo de segurança do paciente, disponível nas áreas.

8.2. INDICADORES

Número de eventos/ incidentes relacionados a falha de comunicação / número de eventos/ incidentes mês x 100.

8.3. RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir a ocorrência de erros relacionados à falha de comunicação entre a equipe de saúde. Espera-se que todo o processo de troca de informação entre pessoas deverá resultar em compreensão sobre o que está sendo comunicado na FCECON.

9. REFERÊNCIAS

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde: uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. [Cartilha na Internet] Brasília, 1. ed., 2013. 174 p. [Acesso em: 05 de março de 2015). Disponível em: http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/images/documentos/livros/Liv ro1-Assistencia_Segura.pdf.

BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA. Eventos adversos relacionados à comunicação no ambiente dos serviços de saúde. In: Assistência Segura: uma reflexão teórica aplicada à pratica. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2013. p. 67 – 68

10. ANEXOS

10.1 Formulário de Passagem de Plantão – Modelo FCECON

10.1.1. Utilizados na UTI

- **SBAR – Equipe de Fisioterapia**

FERRAMENTA SBAR - PASSAGEM DE PLANTÃO DA FISIOTERAPIA EM UTI ADULTO

LEITO:_____

S - SITUAÇÃO	Identificação: _____ Data/Hora _____ Motivo da internação / diagnóstico principal: _____
B - BACKGROUND	Resp. Espontânea? (S/N) O^2 Suplementar? (S/N): _____ Sedação/Bloqueador/Analgesia: _____ Dias em VM: _____ Tipo: ( ) Invasiva ( ) Não Invasiva Modo/Parâmetros VM: _____
A - AVALIAÇÃO	Ausculta Pulmonar: _____ SpO2: __% FR: __ FC: __ PAS: __/__ ( ) Assincronia: ( ) Sim ( ) Não Tipo: _____ Corrigido: (S/N) Força (MRC): ____ Consciência: _____ CUFF: _____
R - RECOMENDAÇÃO	Objetivos: _____ Estratégia ventilatória/desmame: _____ Mobilização: _____ Cuidados: _____ Próximas etapas: _____

Modelo SBAR - Situação, Background, Avaliação e Recomendação | Fisioterapia em UTI Adulto FCECON

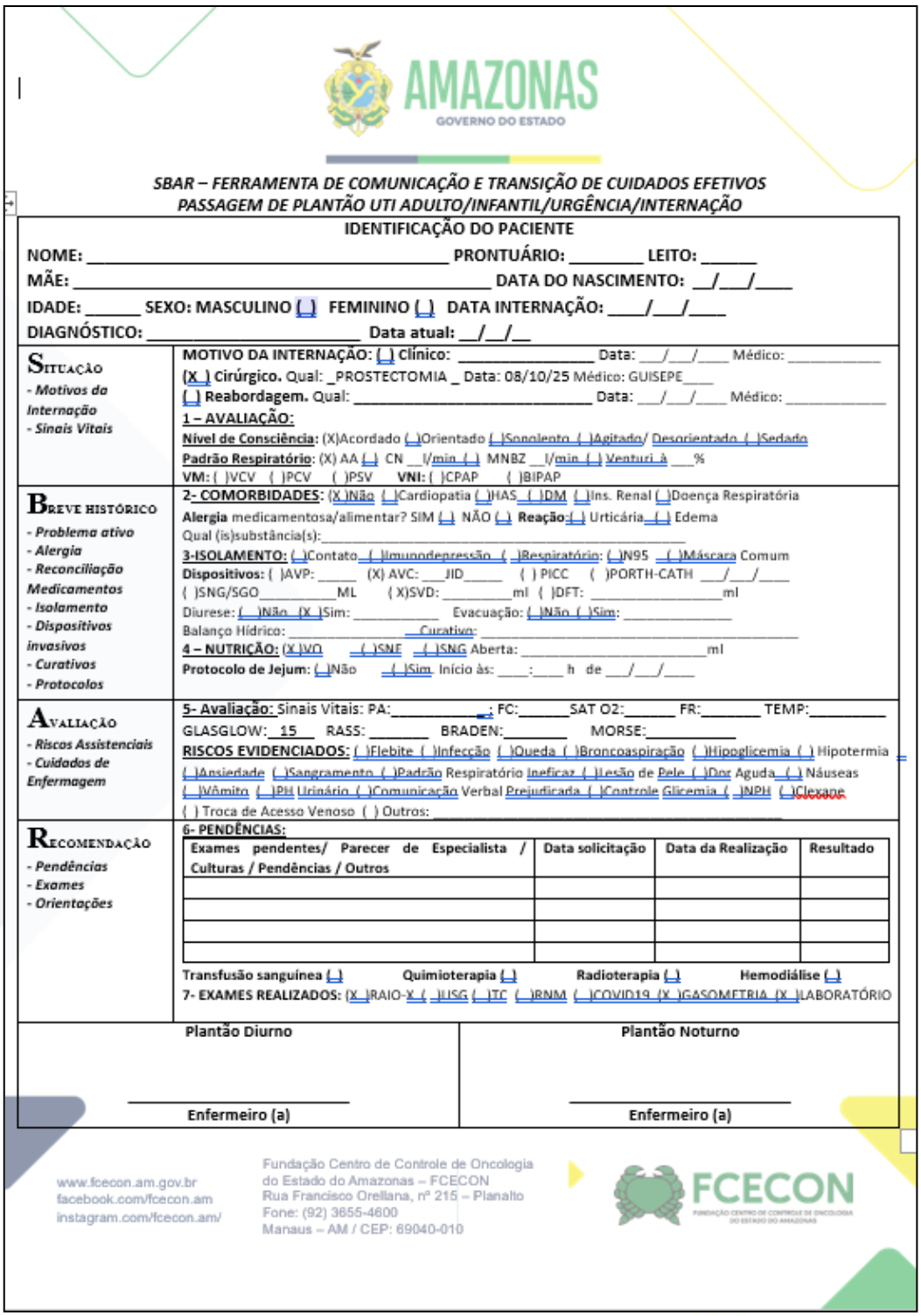
_____

Fisioterapeuta

Data: _____ /_____ /_____

- **SBAR- Equipe de Enfermagem**

  Ferramenta de utilização dos setores: UTI's, Urgência e Internação



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SBAR – FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E TRANSIÇÃO DE CUIDADOS EFETIVOS
PASSAGEM DE PLANTÃO UTI ADULTO/INFANTIL/URGÊNCIA/INTERNAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME: _____ **PRONTUÁRIO:** _____ **LEITO:** _____
MÃE: _____ **DATA DO NASCIMENTO:** __/___/____
IDADE: _____ **SEXO: MASCULINO ( )** **FEMININO ( )** **DATA INTERNAÇÃO:** ____/___/____
DIAGNÓSTICO: _____ **Data atual:** __/__/__

SITUAÇÃO
- Motivos da Internação
- Sinais Vitais

MOTIVO DA INTERNAÇÃO: ( ) Clínico: _____ Data: ___/___/____ Médico: _____
(X) Cirúrgico. Qual: _PROSTECTOMIA _ Data: 08/10/25 Médico: GUISEPE____
( ) Reabordagem. Qual: _____ Data: ___/___/____ Médico: _____
1 – AVALIAÇÃO:
Nível de Consciência: (X)Acordado ( )Orientado ( )Sonolento ( )Agitado/ Desorientado ( )Sedado
Padrão Respiratório: (X) AA ( ) CN __l/min ( ) MNBZ __l/min ( ) Venturi à ___%
VM: ( )VCV ( )PCV ( )PSV **VNI:** ( )CPAP ( )BIPAP

BREVE HISTÓRICO
- Problema ativo
- Alergia
- Reconciliação Medicamentos
- Isolamento
- Dispositivos invasivos
- Curativos
- Protocolos

2- COMORBIDADES: (X)Não ( )Cardiopatia ( )HAS ( )DM ( )Ins. Renal ( )Doença Respiratória
Alergia medicamentosa/alimentar? SIM ( ) NÃO ( ) **Reação:**( ) Urticária ( ) Edema
Qual (is)substância(s):_____
3-ISOLAMENTO: ( )Contato ( )Imunodepressão ( )Respiratório: ( )N95 ( )Máscara Comum
Dispositivos: ( )AVP: _____ (X) AVC: ___JID_____ ( ) PICC ( )PORTH-CATH ___/___/____
( )SNG/SGO_____ML (X)SVD: _____ml ( )DFT: _____ml
Diurese: ( )Não (X)Sim: _____ Evacuação: ( )Não ( )Sim: _____
Balanço Hídrico: _____Curativo: _____
4 – NUTRIÇÃO: (X)VO ( )SNE ( )SNG Aberta: _____ml
Protocolo de Jejum: ( )Não ( )Sim Início às: ____:____ h de ___/___/____

AVALIAÇÃO
- Riscos Assistenciais
- Cuidados de Enfermagem

5- Avaliação: Sinais Vitais: PA:_____: FC:_____SAT O2:_____ FR:_____ TEMP:_____
GLASGLOW: 15 RASS: _____ BRADEN:_____ MORSE:_____
RISCOS EVIDENCIADOS: ( )Flebite ( )Infecção ( )Queda ( )Broncoaspiração ( )Hipoglicemia ( ) Hipotermia ( )Ansiedade ( )Sangramento ( )Padrão Respiratório Ineficaz ( )Lesão de Pele ( )Dor Aguda ( ) Náuseas ( )Vômito ( )PH Urinário ( )Comunicação Verbal Prejudicada ( )Controle Glicemia ( )NPH ( )Clexane
( ) Troca de Acesso Venoso ( ) Outros: _____

RECOMENDAÇÃO
- Pendências
- Exames
- Orientações

6- PENDÊNCIAS:

Exames pendentes/ Parecer de Especialista / Culturas / Pendências / Outros	Data solicitação	Data da Realização	Resultado

Transfusão sanguínea ( ) **Quimioterapia ( )** **Radioterapia ( )** **Hemodiálise ( )**
7- EXAMES REALIZADOS: (X)RAIO-X ( )USG ( )TC ( )RNM ( )COVID19 (X)GASOMETRIA (X)LABORATÓRIO

Plantão Diurno	Plantão Noturno
_____ Enfermeiro (a)	_____ Enfermeiro (a)

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Fone: (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Fone: (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

- **SBAR – Equipe de Médicos (Leitos Lado A)**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PASSAGEM DE PLANTÃO MÉDICA UTI ADULTO LEITOS LADO A					DATA: ___/___/_____	
LEITO	NOME / IDADE/ DN/ DI	DIAGNOSTICOS	DISPOSITIVOS	INFUSÕES	LABS/ COMPLEMENTARES	CONDUTA/ PENDENCIAS
201	NOME: IDADE: DN: DI:					
202	NOME: IDADE: DN: DI:					
203	NOME: IDADE: DN: DI:					

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto /
Fone: (92) 3024-0420 / (92) 3024-0421
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

204	NOME: IDADE: DN: DI:					
205	NOME: IDADE: DN: DI:					
206	NOME: IDADE: DN: DI:					

MEDICO RESPONSÁVEL: _____.

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto /
Fone: (92) 3024-0420 / (92) 3024-0421
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

- **SBAR Equipe de Médicos (Leitos Lado B)**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

PASSAGEM DE PLANTÃO MÉDICA UTI ADULTO LEITOS LADO B					DATA: ___/__/_____	
LEITO	NOME / IDADE/ DI	DIAGNOSTICOS	DISPOSITIVOS	INFUSÕES	LABS/ COMPLEMENTARES	CONDUTA/ PENDENCIAS
207	NOME: IDADE: DN: DI:					
208	NOME: IDADE: DN: DI:					
209	NOME: IDADE: DN: DI:					

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

210	NOME: IDADE: DN: DI:					
211	NOME: IDADE: DN: DI:					

MEDICO RESPONSÁVEL: _____.

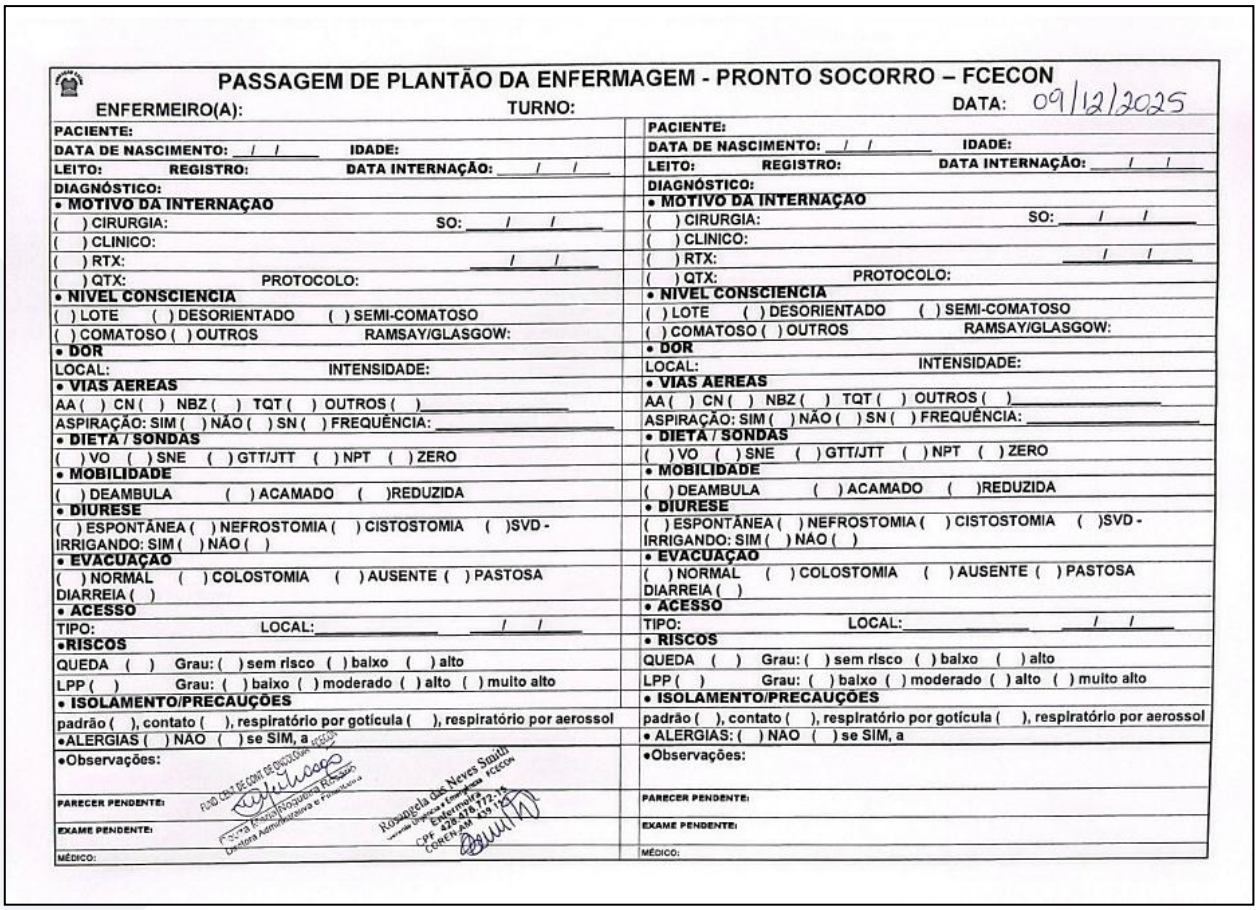
www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto /
Fone: (92) 3024-0420 / (92) 3024-0421
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

10.1.2. Formulário de Passagem de Plantão - Urgência / Emergência

- **Ferramenta de Passagem de Plantão da Equipe de Enfermagem**



PASSAGEM DE PLANTÃO DA ENFERMAGEM - PRONTO SOCORRO – FCECON

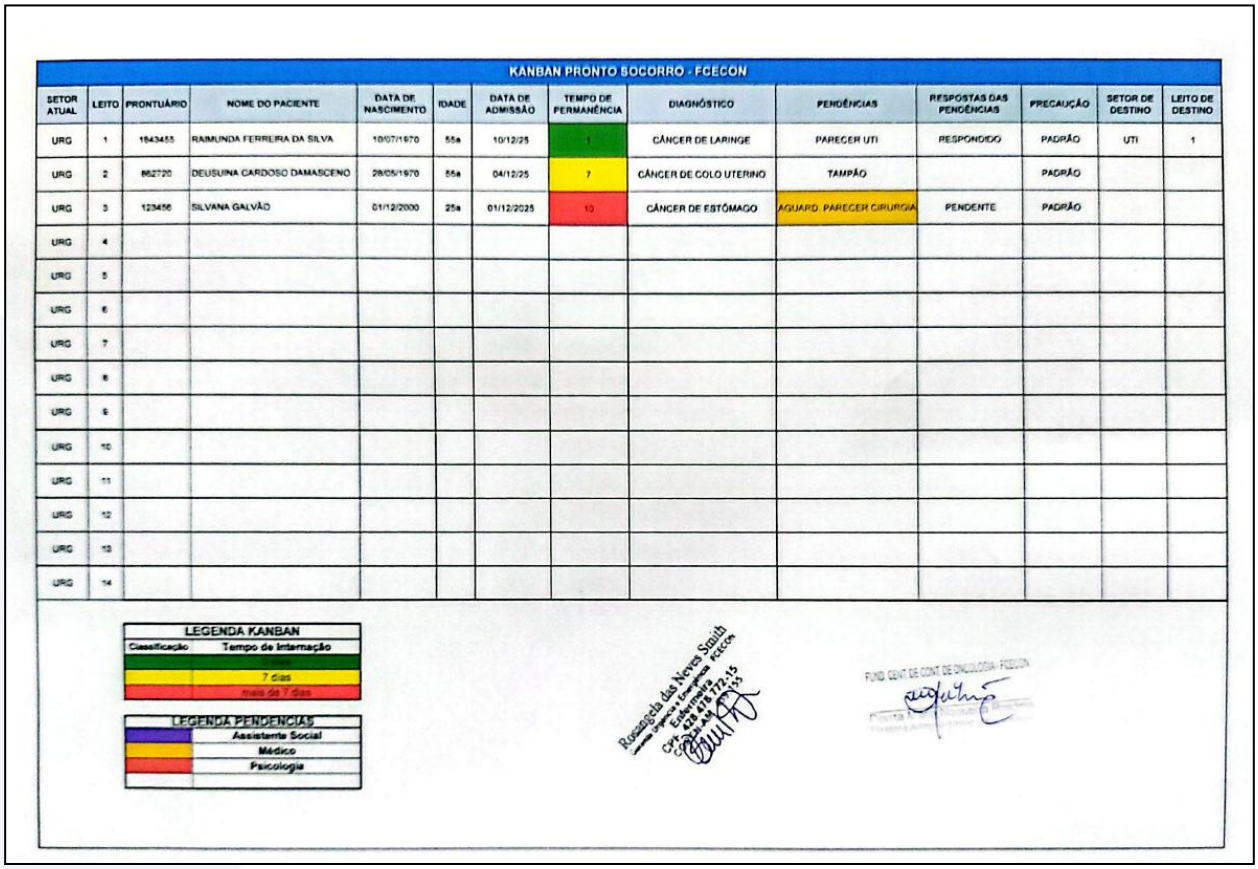
ENFERMEIRO(A): TURNO: DATA: 09/12/2025

PACIENTE:	**PACIENTE:**
DATA DE NASCIMENTO: / / **IDADE:**	**DATA DE NASCIMENTO:** / / **IDADE:**
LEITO: **REGISTRO:** **DATA INTERNAÇÃO:** / /	**LEITO:** **REGISTRO:** **DATA INTERNAÇÃO:** / /
DIAGNÓSTICO:	**DIAGNÓSTICO:**
• MOTIVO DA INTERNAÇÃO	**• MOTIVO DA INTERNAÇÃO**
( ) CIRURGIA: SO: / /	( ) CIRURGIA: SO: / /
( ) CLINICO:	( ) CLINICO:
( ) RTX: / /	( ) RTX: / /
( ) QTX: PROTOCOLO:	( ) QTX: PROTOCOLO:
• NIVEL CONSCIENCIA	**• NIVEL CONSCIENCIA**
( ) LOTE ( ) DESORIENTADO ( ) SEMI-COMATOSO	( ) LOTE ( ) DESORIENTADO ( ) SEMI-COMATOSO
( ) COMATOSO ( ) OUTROS RAMSAY/GLASGOW:	( ) COMATOSO ( ) OUTROS RAMSAY/GLASGOW:
• DOR	**• DOR**
LOCAL: INTENSIDADE:	LOCAL: INTENSIDADE:
• VIAS AEREAS	**• VIAS AEREAS**
AA ( ) CN ( ) NBZ ( ) TQT ( ) OUTROS ( )	AA ( ) CN ( ) NBZ ( ) TQT ( ) OUTROS ( )
ASPIRAÇÃO: SIM ( ) NÃO ( ) SN ( ) FREQUÊNCIA:	ASPIRAÇÃO: SIM ( ) NÃO ( ) SN ( ) FREQUÊNCIA:
• DIETA / SONDAS	**• DIETA / SONDAS**
( ) VO ( ) SNE ( ) GTT/JTT ( ) NPT ( ) ZERO	( ) VO ( ) SNE ( ) GTT/JTT ( ) NPT ( ) ZERO
• MOBILIDADE	**• MOBILIDADE**
( ) DEAMBULA ( ) ACAMADO ( )REDUZIDA	( ) DEAMBULA ( ) ACAMADO ( )REDUZIDA
• DIURESE	**• DIURESE**
( ) ESPONTÂNEA ( ) NEFROSTOMIA ( ) CISTOSTOMIA ( )SVD - IRRIGANDO: SIM ( ) NÃO ( )	( ) ESPONTÂNEA ( ) NEFROSTOMIA ( ) CISTOSTOMIA ( )SVD - IRRIGANDO: SIM ( ) NÃO ( )
• EVACUAÇÃO	**• EVACUAÇÃO**
( ) NORMAL ( ) COLOSTOMIA ( ) AUSENTE ( ) PASTOSA DIARREIA ( )	( ) NORMAL ( ) COLOSTOMIA ( ) AUSENTE ( ) PASTOSA DIARREIA ( )
• ACESSO	**• ACESSO**
TIPO: LOCAL: / /	TIPO: LOCAL: / /
•RISCOS	**• RISCOS**
QUEDA ( ) Grau: ( ) sem risco ( ) baixo ( ) alto	QUEDA ( ) Grau: ( ) sem risco ( ) baixo ( ) alto
LPP ( ) Grau: ( ) baixo ( ) moderado ( ) alto ( ) muito alto	LPP ( ) Grau: ( ) baixo ( ) moderado ( ) alto ( ) muito alto
• ISOLAMENTO/PRECAUÇÕES	**• ISOLAMENTO/PRECAUÇÕES**
padrão ( ), contato ( ), respiratório por gotícula ( ), respiratório por aerossol	padrão ( ), contato ( ), respiratório por gotícula ( ), respiratório por aerossol
•ALERGIAS ( ) NAO ( ) se SIM, a	• ALERGIAS: ( ) NAO ( ) se SIM, a
•Observações:	•Observações:
PARECER PENDENTE:	PARECER PENDENTE:
EXAME PENDENTE:	EXAME PENDENTE:
MÉDICO:	MÉDICO:

- **SBAR – PASSAGEM DE PLANTÃO – EQUIPE MÉDICA (URGÊNCIA / EMERGÊNCIA)**

SETOR: PRONTO SOCORRO - FCECON PASSAGEM DE PLANTÃO MÉDICA		MÉDICO: _____ DATA:_____/_____/_____		
Dados do Paciente	**S - Situação (S)**	**B - Breve Histórico (B)**	**A - Avaliação (A)**	**R - Recomendações**
LEITO: 01 NOME: MARIA DA SILVA FILHA DATA NASC. 01/04/1994 DIAGNÓSTICO: CÂNCER DE COLO UTERINO DATA INTERNAÇÃO: 10/10/2025	Metrorragia e IRA	Paciente com cancêr de colo uterino, realizou QT, RT e BT. Aguardando retorno ambulatorial.	Metrorragia, IRA	Melhora da IRA, aguardando avaliação do nefrologista
LEITO: NOME: DATA NASC. DIAGNÓSTICO: DATA INTERNAÇÃO:				
LEITO: NOME: DATA NASC. DIAGNÓSTICO: DATA INTERNAÇÃO:				
LEITO: NOME: DATA NASC. DIAGNÓSTICO: DATA INTERNAÇÃO:				
LEITO: NOME: DATA NASC. DIAGNÓSTICO: DATA INTERNAÇÃO:				
LEITO: NOME: DATA NASC. DIAGNÓSTICO: DATA INTERNAÇÃO:				

10.3. KANBAM utilizado na Urgência/Emergência



KANBAN PRONTO SOCORRO - FCECON

SETOR ATUAL	LEITO	PRONTUÁRIO	NOME DO PACIENTE	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	DATA DE ADMISSÃO	TEMPO DE PERMANÊNCIA	DIAGNÓSTICO	PENDÊNCIAS	RESPOSTAS DAS PENDÊNCIAS	PRECAUÇÃO	SETOR DE DESTINO	LEITO DE DESTINO
URG	1	1843455	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	10/07/1970	55a	10/12/25	1	CÂNCER DE LARINGE	PARECER UTI	RESPONDIDO	PADRÃO	UTI	1
URG	2	862720	DEUSUINA CARDOSO DAMASCENO	28/05/1970	55a	04/12/25	7	CÂNCER DE COLO UTERINO	TAMPÃO		PADRÃO		
URG	3	123456	SILVANA GALVÃO	01/12/2000	25a	01/12/2025	10	CÂNCER DE ESTÔMAGO	AGUARD. PARECER CIRURGIA	PENDENTE	PADRÃO		
URG	4												
URG	5												
URG	6												
URG	7												
URG	8												
URG	9												
URG	10												
URG	11												
URG	12												
URG	13												
URG	14												

LEGENDA KANBAN	
Classificação	Tempo de Internação
	3 dias
	7 dias
	mais de 7 dias

LEGENDA PENDÊNCIAS
Assistente Social
Médico
Psicologia

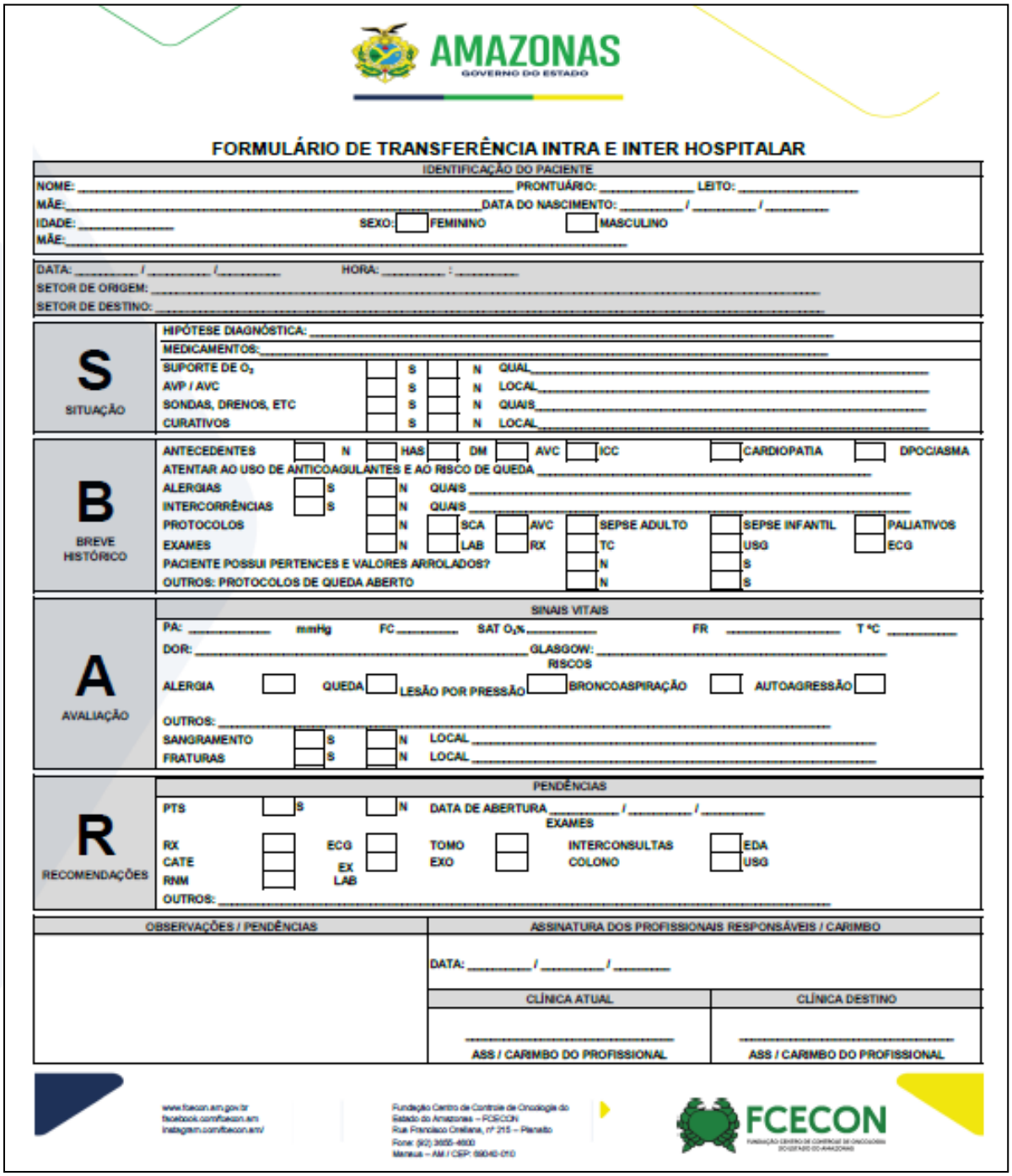
10.4. KANBAM utilizado na UTI

KANBAM - UTI - FCECON													
SETOR ATUAL	LEITO	PRONTUÁRIO	NOME DO PACIENTE	DATA DE NASCIMENTO	IDADE	DATA DE ADMISSÃO	TEMPO DE PERMANÊNCIA	DIAGNÓSTICO	PENDÊNCIAS	RESPOSTAS DAS PENDÊNCIAS	PRECAUÇÃO	SETOR DE DESTINO	LEITO DE DESTINO
UTI	1												
UTI	2												
UTI	3												
UTI	4												
UTI	5												
UTI	6												
UTI	7												
UTI	8												
UTI	9												

LEGENDA KANBAN	
Classificação	Tempo de internação
	3 dias
	7 dias
	mais de 7 dias

LEGENDA PENDÊNCIAS
Assistente Social
Médico
Psicologia

10.5. Formulário de Transferência Intra e Inter Hospitalar – Modelo FCECON



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA INTRA E INTER HOSPITALAR

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME: _____ PRONTUÁRIO: _____ LEITO: _____
MÃE: _____ DATA DO NASCIMENTO: ____/____/____
IDADE: _____ SEXO: ☐ FEMININO ☐ MASCULINO
MÃE: _____

DATA: ____/____/____ HORA: ____:____
SETOR DE ORIGEM: _____
SETOR DE DESTINO: _____

S – SITUAÇÃO

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: _____
MEDICAMENTOS: _____

SUPORTE DE O_2	☐ S	☐ N	QUAL	_____	
AVP / AVC	☐ S	☐ N	LOCAL	_____	
SONDAS, DRENOS, ETC	☐ S	☐ N	QUAIS	_____	
CURATIVOS	☐ S	☐ N	LOCAL	_____	

B – BREVE HISTÓRICO

ANTECEDENTES ☐ N ☐ HAS ☐ DM ☐ AVC ☐ ICC ☐ CARDIOPATIA ☐ DPOCIASMA
ATENTAR AO USO DE ANTICOAGULANTES E AO RISCO DE QUEDA _____

ALERGIAS	☐ S	☐ N	QUAIS	_____							
INTERCORRÊNCIAS	☐ S	☐ N	QUAIS	_____							
PROTOCOLOS		☐ N	☐ SCA	☐ AVC	☐ SEPSE ADULTO		☐ SEPSE INFANTIL		☐ PALIATIVOS		
EXAMES		☐ N	☐ LAB	☐ RX	☐ TC		☐ USG		☐ ECG		
PACIENTE POSSUI PERTENCES E VALORES ARROLADOS?					☐ N		☐ S				
OUTROS: PROTOCOLOS DE QUEDA ABERTO					☐ N		☐ S				

A – AVALIAÇÃO

SINAIS VITAIS
PA: _____ mmHg FC _____ SAT O_2% _____ FR _____ T °C _____
DOR: _____ GLASGOW: _____
RISCOS
ALERGIA ☐ QUEDA ☐ LESÃO POR PRESSÃO ☐ BRONCOASPIRAÇÃO ☐ AUTOAGRESSÃO ☐
OUTROS: _____

SANGRAMENTO	☐ S	☐ N	LOCAL	_____
FRATURAS	☐ S	☐ N	LOCAL	_____

R – RECOMENDAÇÕES

PENDÊNCIAS
PTS ☐ S ☐ N DATA DE ABERTURA ____/____/____
EXAMES

RX	☐	ECG	☐	TOMO	☐	INTERCONSULTAS	☐ EDA
CATE	☐	EX LAB	☐	EXO	☐	COLONO	☐ USG
RNM	☐						

OUTROS: _____

OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS	ASSINATURA DOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS / CARIMBO
	DATA: ____/____/____
	CLÍNICA ATUAL: _____ ASS / CARIMBO DO PROFISSIONAL
	CLÍNICA DESTINO: _____ ASS / CARIMBO DO PROFISSIONAL

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto
Fone: (92) 3655-4600
Manaus – AM / CEP: 69040-010

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

10.3. Round Visita Multidisciplinar – Modelo FCECON

ROTEIRO DE VISITA MULTIPROFISSIONAL

PACIENTE		D Nasc	
DIAGNÓSTICOS			IDAD
LEITO	PRONTUÁRIO:	DIUTI	
Data:		Hora:	

CATEGORIA	ITENS AVALIADOS	NÃO	SIM	NÃO APLIC
IDENTIFICAÇÃO	Paciente possui pulseira de identificação colocada?			
CONFORTO	Paciente Confortável?			
	Realizada mudança de decúbito?			
	Apresenta lesão de pele?			
	Necessidade de Contenção?			
NUTRIÇÃO	Dieta adequada?			
	Jejum? Quantas horas/dias?			
	Glicose controlada?			
	Restrição alimentar?			
	Possui SNG/SOG/SNE?			
	SNG/SOG/SNE pode se removida?			
PREVENÇAÕ DE ITU	Diurese presente?			
	Possui SVD?			
	SVD pode ser removida?			
	Extensão de SVD e/ou coletor com grumos ou raios de sangue?			
	Fixação de SVD adequado e limpo?			
	Higiene de meato urinário realizado 3 x dia?			
PREVENÇÃO DE PAV	Apresenta-se sob VM?			
	Realizada higiene oral 3 x dia com clorexidine oral?			
	Jogo de traqueia acoplado em suporte do ventilador?			
	Cabeceira elevada entre 30°e 45°?			
	Presença de sujidades no jogo de traqueia?			
	Pressão do balonete adequado? 20-22 mmHg ou 25-30 cmH2O?			
	Apresenta critérios para aplicação de TRE?			
	Iniciar desmame ventilatório?			
PREVENÇÃO DE IPCS ASSOCIADA AO CVC	Paciente com CVC?			
	Curativo adequado, limpo, seco e bem aderido a pele?			
	Apresenta sinais flogísticos?			
	Manuseio de CVC adequado?			
	Deve ser mantido? Porque? _____			
ANALGESIA SEDAÇÃO	É possível diminuir ou interromper a sedação?			
	Utilizado escala de sedação?			
	Se agitação, as causa foram reconhecidas e resolvida?			
	Apresenta dor?			
ANTIBIÓTICOS	Realizada solicitação de culturas?			
	É possível descalonar ou suspender o ATB?			
FAMILIARES	Recebe visita dos familiares regularmente?			
	Familiares atualizados sobre o quadro do paciente?			

ROTEIRO DE VISITA MULTIPROFISSIONAL

PLANO DE METAS

PENDENCIAS	METAS	RESULTADOS	DATA/RESPONSÁVEL
EXAMES		( ) ALCANÇADO ( ) NÃO ALCANÇADO	Data: ___/___/_____
PARECER/AVALIAÇÃO		( ) ALCANÇADO ( ) NÃO ALCANÇADO	Data: ___/___/_____
PROCEDIMENTOS		( ) ALCANÇADO ( ) NÃO ALCANÇADO	Data: ___/___/_____
OUTROS		( ) ALCANÇADO ( ) NÃO ALCANÇADO	Data: ___/___/_____

PROFISSIONAIS		OBSERVAÇÕES
Função	Nome	
( ) Médico Coordenador UTI		
( ) Médico Diarista		
( ) Médico SCIH		
( )Enfermeiro Coordenador		
( )Enfermeiro UTI		
( ) Enfermeiro CCIH		
( ) Técnico Enfermagem		
( ) Farmacêutico		
( )Fisioterapeuta		
( )Psicólogo		
( ) Nutricionista		
( ) Fonoaudiologo		
( ) NSP		

www.fcecon.am.gov.br
facebook.com/fcecon.am
instagram.com/fcecon.am/

Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas – FCECON
Rua Francisco Orellana, nº 215 – Planalto / Fone: (92) 3024-0420 / (92) 3024-0421

FCECON
FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	10/12/2025	Elaboração do Protocolo da Meta 2 – Comunicação Efetiva

Elaboração: ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Assinado de forma digital por ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Dados: 2025.12.19 11:42:49 -04'00' **Coordenação do Núcleo de Segurança do Paciente** Andréa Lima de Souza Marques	**Data:** 10/12/2025
Revisão:	**Data:**
Aprovação: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 **Diretora Técnica** Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira	**Data:**